Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho

Rua Bento Gonçalves, 151 - Bairro: Vargas - CEP: 99500000 - Fone: (54) 3330-2411 - Email: frcarazinh1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002021-40.2021.8.21.0009/RS

AUTOR: ROMEU NEDEFF FILHO
RÉU: MUNICÍPIO DE CARAZINHO
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

1. Relatório

Romeu Nedeff Filho ajuizou a presente ação ordinária em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Carazinho.

Em sua inicial, o requerente sustenta ser portador de câncer de próstata, em estágio clínico IV (metástases ósseas), patologia classificada sob CID 10 C61, necessitando fazer uso do medicamento XTANDI - ENZALUTAMIDA, na dose de 160 mg por dia, pelo período de 6 meses, correspondendo a 4 cápsulas de 40mg ao dia.

Aduz que o preço do tratamento é elevado, o que o torna incompatível com a renda mensal.

Argumenta que a saúde é direito fundamental.

Destaca a responsabilidade do Poder Público em fornecer o tratamento.

Requer, em sede de tutela provisória de urgência, com confirmação ao final, o fornecimento do medicamento XTANDI - ENZALUTAMIDA 160 mg por dia, pelo período de 6 meses, ou os recursos financeiros equivalentes para aquisição do tratamento. Pede o benefício da assistência judiciária gratuita e junta documentos em evento 1.

Deferida a gratuidade da Justiça e a tutela provisória de urgência (evento 4).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação em evento 12.

Inicialmente, sustenta que o tratamento requerido integra os programas de alta complexidade, de responsabilidade do Ministério da Saúde, disponibilizado pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

Aduz a ilegitimidade passiva, tendo em vista que o procedimento requerido é de responsabilidade da União Federal.

Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, seja acolhida a arguição no tocante ao cumprimento do tema 793, do STF, determinando-se a inclusão da União no polo passivo.

O Município de Carazinho, por sua vez, apresentou contestação ao evento 15.

Preliminarmente, requereu a inclusão da União Federal no polo passivo, aplicando-se a Tese de Repercussão Geral n. 793 do STF, tendo em vista que o medicamento postulado não está inserido em nenhuma das listas do SUS.

No mérito, deixou de apresentar contestação ao pedido de fornecimento de medicamento, por força da Tese de Repercussão Geral n° 793 do STF.

Réplicas em eventos 17 e 20.

O Ministério Público declinou de sua intervenção no presente feito (evento 23).

Instadas as partes sobre as demais provas que pretendiam produzir, o Estado do Rio Grande do Sul requereu a expedição de ofício ao Hospital de Caridade de Carazinho para informar o valor da APAC referente ao tratamento oncológico do paciente, bem como o montante dos valores que já foram e que ainda serão repassados pelo Ministério da Saúde.

A parte autora, em petição acostada ao evento 36, pugnou pela substituição da medicação deferida em antecipação de tutela, alegando que, apesar do tratamento realizado, a patologia evoluiu, requerendo, assim, a substituição do medicamento ENSALUTAMIDA pelo medicamento APALUTAMIDA 60 mg, na dose de 4 cápsulas ao dia, conforme receituário em anexo.

Intimado a se manifestar sobre o novo pedido, o Estado do Rio Grande do Sul impugnou a pretensão da parte autora de inclusão de novo medicamento no curso da lide (evento 45).

O Município, em consonância, discordou com o aditamento do pedido (evento 47).

Admitido, em decisão fundamentada, o aditamento do pedido, deferiu-se a tutela provisória de urgência e foi concedida a reabertura do prazo contestacional (evento 50).

O Estado do Rio Grando do Sul apresentou contestação ao evento 55.

Inicialmente, sustenta que o tratamento requerido integra os programas de alta complexidade, de responsabilidade do Ministério da Saúde, disponibilizado pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

Aduz a ilegitimidade passiva, tendo em vista que o procedimento requerido é de responsabilidade da União Federal.

Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, seja acolhida a arguição no tocante ao cumprimento do tema 793, do STF, determinando-se a inclusão da União no polo passivo.

Em decisão de saneamento do feito, fora rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos reqieridos e indeferido o pedido de inclusão da União no polo passivo (evento 139).

Intimado, o ERGS juntou aos autos o laudo da SES, o qual concluiu acerca da possibilidade de substituição do medicamento postulado pela alternativa terapêutica que integra as listas do SUS (evento 145, "Laudo 2").

Em ofício acostado ao evento 155, o Hospital de Caridade de Carazinho informou o valor das APAC´s que o autor possui no serviço de oncologia (evento 155).

O Ministério público, por meio de parecer, deixou de intervir no presente feito (evento 163).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO.

PASSO A DECIDIR.

2. Fundamentação

2.1 Preliminar: Ilegitimidade passiva e chamamento ao processo da União

A preliminar de ilegitimidade passiva *ad causam* levantada pelo réu já foi objeto de análise (evento 139).

O pedido de inclusão da União no polo passivo também foi indeferido, de maneira fundamentada, por ocasião da decisão do evento 139, porém, a questão referente ao julgamento do Tema n. 793 voltou a ser debatida pelo Supremo Tribunal Federal em julgados mais recentes, motivo pelo qual passo a analisar novamente a questão.

Tratando-se de uma prestação pública de saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 793, decidiu que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Posteriormente, em julgamento de embargos de declaração sugeridos em face do aludido Acórdão, o Supremo Tribunal Federal ratificou a solidariedade, embora tenha recomendado que o cumprimento seja dirigido, sempre que possível, ao ente federado competente e que seja determinado o ressarcimento quando exigível.

Ademais, o entendimento que vem sendo adotado pelo E. TJ/RS é no sentido de que a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União no polo passivo, visto se tratar de obstáculo à garantia fundamental do direito à saúde.

Sobre o tema, transcreve-se recente julgado:

> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência desta corte possui o entendimento de que os entes públicos são solidários no atendimento das questões relativas à saúde, de modo que o necessitado pode exigir o cumprimento da obrigação prevista na Constituição Federal como direito fundamental de qualquer um dos entes públicos. 2. No tocante à competência, é verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 855.178, estabelecendo a seguinte tese (TEMA 793): "Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. A Câmara, contudo, tem entendido que a aludida tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 4. Em relação ao Tema 793, o STF "tão somente fixou o direcionamento para ressarcimento dos valores, não havendo imposição para litisconsórcio passivo necessário, nos termos do inteiro teor do acórdão". 6. E no julgamento do Resp. 1203244/SC sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 686), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o chamamento ao processo da União nas demandas propostas contra os demais entes federativos para o fornecimento de medicamentos não é impositivo, visto se tratar de obstáculo inútil à garantia fundamental do direito à saúde. 7. Precedentes da Câmara e do TJ/RS em casos idênticos ao dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51954609220218217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 24-03-2022).*

No presente caso, a parte requerente dirige a sua pretensão ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Carazinho, o que se admite em face da aludida solidariedade, não tendo o que se falar em inclusão da União no polo passivo.

2.2. Mérito

Inicialmente, quanto à alegação do Estado de que o tratamento postulado pelo autor é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, nos Centros de Alta Complexidade em Oncologia, observa-se que, em razão da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.535/98, não há óbice a que o cidadão exija o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes estatais que detém a responsabilidade pela saúde pública atribuída pela ordem constitucional, até porque o SUS integra-os de forma sistematizada e descentralizada.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE PORTO ALEGRE. PESSOA CARENTE DE RECURSOS E ACOMETIDA DE LINFOMA NÃO HODKING (CID C 83.0) NO MEMBRO SUPERIOR, COM DIFICULDADE DE MOBILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REJEITADA. 1. Ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado que vai afastada. Responsabilidade solidária dos entes públicos que autoriza a parte necessitada a postular em juízo o seu tratamento de saúde perante qualquer dos entes da Federação. Responsabilidade dos entes públicos que não se limita às listas administrativas, ainda que a existam os CACONs para tratamento específico de oncologia. Precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça colacionado. 2. O autor, representado por sua mãe, trata-se de pessoa carente de recursos financeiros e acometido de Linfoma Não Hodking (CID C 83.0) no membro superior, com dificuldade de mobilização, necessitando ser internado em hospital de Porto Alegre. Dever de custeio pelos entes públicos, uma vez que implementados os requisitos postos na legislação de regência. Superdireito à saúde que deve prevalecer sobre os princípios orçamentários e financeiros esgrimidos na defesa pelo ente público. Ausência de afronta aos princípios da independência e autonomia dos Poderes. 3. Transferência do Município de Camaquã para Porto Alegre e internação ocorrida no transcurso do processo. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70029156882, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 15/03/2012)

Registre-se que é entendimento, **ainda majoritário**, mesmo após o julgamento do STF sobre o Tema 793, a responsabilidade solidária entre os entes no tocante à saúde. Cuida-se, **nessa perspectiva**, de litisconsórcio facultativo, competindo à parte requerente a propositura da ação contra o ente que melhor lhe convir.

Em casos análogos, manifestou-se o E. TJ/RS:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CACON. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO. 1. Preliminarmente afastada. Possibilidade de julgamento monocrático do recurso com base no entendimento pacífico do órgão fracionário acerca da matéria posta, tendo em vista o conteúdo da Súmula 568 do STJ e do art. 206, XXXVI, do Regimento Interno desta Corte. ***2. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da*** *União****, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo*** *solidária* ***a*** *responsabilidade* ***dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793. 3. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a*** *responsabilidade solidária* ***dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o*** *medicamento* ***pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela*** *União****. 4. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do tratamento, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico.*** *5. Não obstante a alegação de se tratar de medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que o não uso da medicação impõe risco de morte ao paciente. 6. Somente nos casos em que a ação demande de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA é que, necessariamente, será proposta em face da União, segundo definição do STF na apreciação do Tema de Repercussão Geral nº 500. 7. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70084132174, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-07-2020)[grifei]*

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ***Litisconsórcio necessário com a*** *União****. No julgamento dos embargos de declaração opostos, em face do acórdão proferido nos autos do recurso extraordinário nº 855.178 (rg) – tema 793 –, o supremo tribunal federal reafirmou o entendimento já consolidado, no âmbito daquela corte superior, a respeito da*** *responsabilidade solidária* ***dos entes federados pelo fornecimento de serviços de saúde e limitou-se a assegurar a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos. A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo*** *solidária* ***a obrigação no fornecimento de*** *medicamentos****/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos. Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria. Com efeito, incumbe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a*** *União****, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento*** *médico****, sem relação direta com o cidadão.*** *Assim, imperiosa a reforma da sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC. Aplica-se, pois, no caso dos autos, a normativa prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, o qual dispõe que "se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito". Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. O entendimento acerca da solidariedade dos entes da federação, nas demandas prestacionais na área da saúde, restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE com Repercussão Geral (Tema 793). Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Ibrutinib. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade – sob pena de arcar com os custos do tratamento –, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON). APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084347970, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-07-2020) [grifei]*

No mérito propriamente dito, o artigo 196 da Constituição da República dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Essa norma tem sido objeto de amplo debate doutrinário e jurisprudencial, inclusive com a realização de audiência pública sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, com o intuito de compatibilizar o que se convencionou chamar de "mínimo existencial" e "reserva do possível", dada a essencialidade do direito e a escassez dos recursos públicos.

Já encerradas as audiências públicas, o Excelso Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão singular proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na STA 175, que envolvia um pedido de suspensão de liminar deferida contra o Poder Público para o fornecimento de medicamentos, da qual extraio estas relevantes conclusões, atinentes a pedidos de medicamentos:

> *"Esse foi um dos primeiros entendimentos que sobressaiu nos debates ocorridos na Audiência Pública-Saúde: no Brasil, o problema talvez não seja de judicialização ou, em termos mais simples, de interferência do Poder Judiciário na criação e implementação de políticas públicas em matéria de saúde, pois o que ocorre, na quase totalidade dos casos, é apenas a determinação judicial do efetivo cumprimento de políticas públicas já existentes. Esse dado pode ser importante para a construção de um critério ou parâmetro para a decisão em casos como este, no qual se discute, primordialmente, o problema da interferência do Poder Judiciário na esfera dos outros Poderes. Assim, também com base no que ficou esclarecido na Audiência Pública, o primeiro dado a ser considerado é a existência, ou não, de política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada pela parte. Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. Nesses casos, a existência de um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente. Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação. (...) Como ficou claro nos depoimentos prestados na Audiência Pública, é vedado à Administração Pública fornecer fármaco que não possua registro na ANVISA. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Inclusive, como ressaltado pelo próprio Ministro da Saúde na Audiência Pública, há necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos. Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial. Situação diferente é a que envolve a inexistência de tratamento na rede pública. Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema de Saúde brasileiro."*

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1657156, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.*
>
> *1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)*

No caso dos autos, conforme restou esclarecido pelo médico assistente do autor, a referida medicação *"É ÚNICA NO MERCADO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR QUALQUER OUTRA, NÃO HÁ SIMILAR. INEXISTE NAS TABELAS E LISTAS SUS, INCLUSIVE NÃO É CONTEMPLADA, COMO REFERIDO, NO ROL DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, CUJA TABELA SÓ CONTEMPLA QUIMIOTERAPIAS E A ENZALUTAMIDA NÃO É QUIMIOTERAPIA, PERTENCENDO A OUTRA CLASSE DE MEDICAÇÕES, ADMINISTRADOS POR VIA ORAL".* (evento 36, "Atestado Médico 2")

A incapacidade financeira decorre do alto custo da medicação, conjugado com a hipossuficiência da parte requerente e, além disso, o medicamento possui registro na Anvisa.

Assim, possível a condenação do ente público ao fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS.

Assim, comprovada a excepcionalidade do caso, o fornecimento do tratamento como requerido é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Com esses fundamentos, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por Romeu Nedeff Filho em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Carazinho para condená-los ao fornecimento do medicamento APALUTAMIDA 60 mg, na dose de 4 cápsulas ao dia, conforme receituário acostado ao evento 36 ("Receituário 3"), enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Por fim, condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do novo CPC, considerando os parâmetros fixados nas alíneas do parágrafo anterior, **especialmente o princípio da modicidade e a possibilidade de direcionamento do cumprimento para a a União**, dividido em 50% a cada parte.

Os requeridos são isentos de custas, mas devem arcar com eventuais despesas, bem como a restituição da taxa única se adiantada pela parte requerente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Considerando o disposto 1.010, § § 1º, 2º e 3º do novo CPC, interposto recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões e em seguida remeta-se ao Tribunal de Justiça. Observar a hipótese do § 2º do dispositivo citado.

Documento assinado eletronicamente por **MARCEL ANDREATA DE MIRANDA, Juiz de Direito**, em 28/4/2022, às 14:49:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10017915039v15** e o código CRC **b72ccd70**.